



## Percorsi, Sistemi e Flussi Sanitari dei Servizi Territoriali

Dalla Governance ai Servizi: logiche, strumenti e interoperabilità

17 Marzo 2026

Revisione del Documento: **3.0**

|              | Struttura | Nome                                | Data       |
|--------------|-----------|-------------------------------------|------------|
| Redatto da   | Almaviva  | Claudio Pastore – Federica Martello | 02/12/2025 |
| Approvato da |           |                                     |            |

### Registro delle Revisioni

| Revisione | Data       | Sintesi delle modifiche                                      |
|-----------|------------|--------------------------------------------------------------|
| 1.0       | 02/12/2025 | Prima stesura                                                |
| 1.5       | 03/12/2025 | Revisione flussi                                             |
| 2.0       | 09/12/2025 | Rappresentazioni grafiche e casi d'uso                       |
| 2.5       | 15/12/2025 | Approfondimenti                                              |
| 2.6       | 05/01/2026 | Correzione ed affinamento definizioni e processi             |
| 2.7       | 16/01/2026 | Tavole iconografiche                                         |
| 2.8       | 26/01/2026 | Affinamenti vari su descrizioni e tavole, aggiunta appendice |
| 2.9       | 17/02/2026 | Flussi, struttura e regole di composizione                   |
| 3.0       | 17/03/2026 | Ristrutturazione e separazione Percorsi, Erogatori e Flussi  |

**Almaviva S.p.A.**

Via di Casal Boccone 188/190 - 00137 Roma - Tel. 06 3993 1 - Fax 06 3993 5775  
Capitale sociale € 154.899.065,00 i.v. - Registro imprese Roma - C.F./P. IVA 08450891000 – R.E.A. 1094997

[www.almaviva.it](http://www.almaviva.it)

# Sommario

|                                                                                       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Introduzione.....                                                                     | 4  |
| Glossario.....                                                                        | 5  |
| Flussi informativi (NSIS / regionali).....                                            | 5  |
| Attori dell'assistenza territoriale (DM 77/2022).....                                 | 5  |
| Gestori (Governance) - coordinano, attivano, supervisionano.....                      | 5  |
| Erogatori (Strutture operative) - erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie..... | 5  |
| Termini di processo e valutazione.....                                                | 6  |
| Canali e servizi di accesso.....                                                      | 6  |
| Termini applicativi e infrastrutturali.....                                           | 6  |
| Modello Informativo: Percorsi, Flussi NSIS e Flussi Regionali.....                    | 7  |
| Distinzione tra Percorsi, Flussi NSIS e Flussi Regionali.....                         | 7  |
| 1. Percorsi (DM 77/2022) – Il modello organizzativo.....                              | 7  |
| 2. Flussi NSIS – Il modello informativo nazionale.....                                | 7  |
| 3. Flussi Territoriali/Regionali – Il modello informativo Veneto.....                 | 7  |
| Caratteristiche generali dei flussi informativi (NSIS e regionali).....               | 8  |
| a) Tracciati strutturati.....                                                         | 8  |
| b) Identificativi coerenti.....                                                       | 8  |
| c) Modello posizionale.....                                                           | 8  |
| d) Validazione multilivello.....                                                      | 8  |
| e) Periodicità variabile.....                                                         | 8  |
| Introduzione ai grafici dei flussi.....                                               | 9  |
| Grafico 1 – Alberatura NSIS (flussi informativi rilevanti).....                       | 9  |
| Grafico 2 – Flussi informativi regionali del Veneto.....                              | 9  |
| Grafico 3 – Attori dell'assistenza territoriale (DM 77/2022).....                     | 10 |
| Principali flussi in ambito territoriale.....                                         | 11 |
| 1. DOMICILIARITÀ.....                                                                 | 11 |
| 1.1 Flusso NSIS: SIAD – Sistema Informativo Assistenza Domiciliare.....               | 11 |
| 1.2 Flussi regionali: ADI e CAD (Regione Veneto).....                                 | 11 |
| 2. RIABILITAZIONE.....                                                                | 11 |
| 2.1 Flusso NSIS: SIAR – Sistema Informativo Assistenza Riabilitativa.....             | 11 |
| 2.2 Flusso regionale storico: URT (Regione Veneto).....                               | 12 |
| 3. CURE INTERMEDIE.....                                                               | 12 |
| 3.1 Flusso NSIS: SIOC – Sistema Informativo Ospedale di Comunità.....                 | 12 |
| 3.2 Recepimento regionale Veneto (SIOC esteso).....                                   | 12 |
| 4. CURE PALLIATIVE.....                                                               | 12 |
| 4.1 Flusso NSIS: HOSPICE.....                                                         | 12 |
| 4.2 Cure palliative domiciliari: UCP-DOM (rilevazione via SIAD).....                  | 13 |
| Percorsi della sanità territoriale.....                                               | 14 |
| 1. Origine del bisogno.....                                                           | 14 |
| 2. Accesso al sistema territoriale.....                                               | 14 |
| 3. Valutazione del bisogno.....                                                       | 14 |
| 4. Percorsi post-ricovero e dimissione protetta.....                                  | 14 |
| 4.1 Dimissione protetta.....                                                          | 14 |
| 4.2 Dimissione assistita.....                                                         | 15 |
| 5. Coordinamento del percorso territoriale (COT).....                                 | 15 |
| 6. Attivazione dei servizi territoriali.....                                          | 15 |
| 7. Conclusione del percorso.....                                                      | 15 |
| Diagramma “Attori–Governance–Flussi” (DM 77/2022 – NSIS).....                         | 16 |
| PUA – Funzioni, organizzazione e implementazione applicativa.....                     | 17 |
| 1. Ruolo e finalità.....                                                              | 17 |
| 2. Collocazione nel modello territoriale.....                                         | 17 |
| 3. Funzioni operative.....                                                            | 17 |
| 3.1 Accoglienza e registrazione del bisogno.....                                      | 17 |
| 3.2 Valutazione preliminare.....                                                      | 17 |
| 3.3 Smistamento verso gli attori competenti.....                                      | 17 |
| 3.4 Comunicazione e raccordo.....                                                     | 17 |
| 4. Relazioni con gli altri attori del territorio.....                                 | 18 |
| 5. Cosa il PUA NON fa.....                                                            | 18 |
| PUA – Modello funzionale offerto da RTI.....                                          | 19 |
| Mappatura e automazione (file di configurazione).....                                 | 19 |
| Livelli e attori.....                                                                 | 19 |
| Modalità di smistamento dalla 116117.....                                             | 19 |



|                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------|----|
| Regole operative.....                                                    | 19 |
| Governance – PUA Master.....                                             | 19 |
| Stati minimi e transizioni.....                                          | 20 |
| Semantica di chiusura.....                                               | 20 |
| Rendicontazione essenziale.....                                          | 20 |
| Comunicazioni al cittadino (ingresso da 116117).....                     | 20 |
| PUA - Diagramma esteso .....                                             | 20 |
| PUA - Casi d'uso (esempi).....                                           | 21 |
| 1 – Smistamento indiretto .....                                          | 21 |
| 2 – Smistamento diretto .....                                            | 21 |
| 3 – Smistamento ibrido .....                                             | 21 |
| 4 – Modello semplificato (2° livello = UE).....                          | 21 |
| 5 – Fallback PUA Master (governance/riassegnazione).....                 | 21 |
| COT - Funzioni, organizzazione e implementazione applicativa .....       | 22 |
| Ruolo.....                                                               | 22 |
| Segnalazioni in ingresso .....                                           | 22 |
| Azioni della COT.....                                                    | 22 |
| Interfacce operative.....                                                | 22 |
| Nota terminologica .....                                                 | 22 |
| COT Diagramma esteso .....                                               | 22 |
| Tavole Iconografiche .....                                               | 23 |
| Accesso operativo .....                                                  | 23 |
| Operatività Applicativa .....                                            | 23 |
| Architettura sistemi .....                                               | 24 |
| Appendice A – Note operative essenziali .....                            | 25 |
| 116117 (LifeContinuity).....                                             | 25 |
| CA (MedicalCare) .....                                                   | 25 |
| <b>PUA – Comportamenti applicativi</b> .....                             | 25 |
| Appendice B – Implementazioni applicative attuali .....                  | 26 |
| Appendice C – Applicativi utilizzati rilevamento 06/2025 ( DRAFT ) ..... | 27 |
| Bibliografia .....                                                       | 28 |



## Introduzione

La sanità territoriale rappresenta oggi l'asse strategico delle politiche nazionali in tema di continuità delle cure, integrazione degli interventi e presa in carico della cronicità. Il nuovo modello, definito dal **DM 77/2022**, ridefinisce ruoli, attori e strutture dell'assistenza territoriale – dai Punti Unici di Accesso (PUA) alle Centrali Operative Territoriali (COT), dagli Ospedali di Comunità alle Unità Riabilitative Territoriali e agli Hospice.

Parallelamente, il **NSIS – Nuovo Sistema Informativo Sanitario** fornisce il quadro nazionale dei **flussi informativi**, ossia l'insieme dei tracciati, delle regole tecniche e delle periodicità che consentono la raccolta standardizzata dei dati sulle prestazioni territoriali, domiciliari, riabilitative, intermedie e residenziali. I flussi NSIS garantiscono uniformità, interoperabilità e monitoraggio dei LEA, costituendo il riferimento tecnico centrale per tutte le Regioni.

La comprensione dei flussi informativi richiede l'analisi coordinata di quattro dimensioni fondamentali:

- **Origine e destinazione dei dati**, per identificare i punti in cui le informazioni vengono generate e quelli in cui vengono recepite.
- **Relazioni tra attori e categorie di processo**, distinguendo governance, supervisione e attivazione dei servizi.
- **Normativa nazionale**, che definisce standard, obblighi di trasmissione e tracciati (NSIS, DM 77/2022).
- **Applicativi e infrastrutture**, che permettono la raccolta, l'integrazione e la trasmissione dei dati ai sistemi regionali e nazionali.
- 

Il presente documento integra questi due livelli – organizzativo e informativo – offrendo una lettura coordinata dei percorsi territoriali, dei flussi NSIS e regionali e degli applicativi che li supportano, con l'obiettivo di descrivere in modo chiaro e unitario il funzionamento complessivo del sistema.

**Il documento fornisce quindi una visione strutturata e coerente del sistema territoriale regionale, raccordando modelli organizzativi, flussi informativi e strumenti applicativi in un quadro unitario di funzionamento e interoperabilità.**

Nota di metodo: «Se non sai spiegarlo facilmente, non l'hai capito.»



## Glossario

### Flussi informativi (NSIS / regionali)

**SIAD** – *Sistema Informativo Assistenza Domiciliare*

Rileva attività domiciliari sanitarie e sociosanitarie (ADI, CAD, cure palliative) tramite tracciati di presa in carico e attività.

**ADI** – *Assistenza Domiciliare Integrata*

Percorso di assistenza domiciliare continuativa e multidisciplinare; rilevata all'interno del flusso SIAD (non è un flusso autonomo).

**CAD** – *Cure Ambulatoriali Domiciliari*

Prestazioni domiciliari puntuali e non continuative (medicazioni, terapie), rilevate nel SIAD.

**SIAR** – *Sistema Informativo Assistenza Riabilitativa*

Flusso NSIS per trattamenti riabilitativi residenziali e semiresidenziali; sostituisce progressivamente la rilevazione URT regionale.

**URT (flusso)** – *Unità Riabilitative Territoriali (flusso regionale storico)*

Rilevazione regionale delle attività riabilitative territoriali; oggi progressivamente superata da SIAR.

**SIOC** – *Sistema Informativo Ospedale di Comunità*

Flusso NSIS dedicato ai ricoveri negli Ospedali di Comunità: anagrafica, ricovero, attività, valutazioni e dimissioni.

**HOSPICE (HOS)** – *Flusso NSIS Hospice*

Rileva l'attività delle strutture residenziali di cure palliative.

**FAR** – *Assistenza Residenziale e Semiresidenziale*

Flusso NSIS dedicato a RSA e centri diurni; monitora la residenzialità continuativa.

**SDO** – *Scheda di Dimissione Ospedaliera*

Flusso NSIS ospedaliero; fondamentale per i percorsi di dimissione protetta e raccordo con i servizi territoriali.

**SIAS** – *Assistenza Specialistica Ambulatoriale*

Flusso NSIS relativo alle prestazioni ambulatoriali, incluse quelle riabilitative.

### Attori dell'assistenza territoriale (DM 77/2022)

**Gestori (Governance)** - coordinano, attivano, supervisionano

**CdC** – *Casa della Comunità*

Punto di accesso, coordinamento e integrazione dei servizi territoriali.

**PUA** – *Punto Unico di Accesso*

Accoglie il bisogno del cittadino, orienta e instrada verso il setting appropriato.

**COT** – *Centrale Operativa Territoriale*

Nodo di governance che coordina i percorsi, supervisiona le dimissioni protette e garantisce la continuità ospedale-territorio.

**Distretto Sanitario** –

Livello organizzativo responsabile delle CdC e della rete territoriale.

**Azienda ULSS / Regione** –

Enti responsabili della programmazione, del governo e della trasmissione dei flussi informativi.

**Erogatori (Strutture operative)** - erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie

**OdC** – *Ospedale di Comunità*

Struttura di cure intermedie per ricoveri brevi a bassa/media intensità.

**URT (struttura)** – *Unità Riabilitative Territoriali*

Strutture residenziali riabilitative post-acuzie.

**Hospice** – Struttura residenziale dedicata alle cure palliative in fase avanzata.

**UCP-DOM** – *Unità di Cure Palliative Domiciliari*

Servizio territoriale che eroga cure palliative domiciliari tramite équipe multiprofessionali, garantendo controllo dei sintomi e supporto alla famiglia.

**RSA** – *Residenza Sanitaria Assistenziale*

Struttura sociosanitaria di lunga durata; non classificata come struttura intermedia.



### **Servizi di Assistenza Domiciliare –**

ADI (integrata), CAD (ambulatoriale domiciliare), cure palliative domiciliari.

**MMG / PLS** – Medico di Medicina Generale / Pediatra di Libera Scelta

Erogano prestazioni sanitarie primarie e continuità assistenziale sul territorio.

**IFeC / IfoC** – *Infermiere di Famiglia e Comunità*

Professionista territoriale con funzioni educative, preventive e assistenziali.

### **Termini di processo e valutazione**

**Dimissione protetta** – Dimissione ospedaliera con attivazione di servizi territoriali (ADI, OdC, URT, Hospice).

**Dimissione assistita** – Dimissione ospedaliera con controlli programmati senza attivazione di servizi territoriali.

**Bisogno** – Esigenza sanitaria o sociosanitaria che attiva la valutazione da parte di PUA o UVMD.

**PIC** – *Presa in Carico*

Attivazione formale del percorso assistenziale da parte del servizio competente.

**PAI** – *Piano Assistenziale Individuale*

Documento UVMD con obiettivi, interventi e responsabilità del percorso.

**PRI** – *Piano Riabilitativo Individuale*

Documento clinico specifico per i percorsi riabilitativi.

**Setting definitivo** – Struttura/servizio che eroga effettivamente la prestazione.

**Case Manager** – Figura responsabile del coordinamento del percorso individuale.

**UVMD** – *Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale*

Team multidisciplinare che esegue valutazioni complesse e definisce il PAI.

**SVaMA** – *Scheda di Valutazione Multidimensionale dell'Anziano*

Strumento regionale per l'accesso a residenzialità, semi residenzialità e domiciliarità.

**UDO** – *Unità di Offerta*

Categoria amministrativa che classifica strutture e servizi nei flussi regionali.

**LEA** – *Livelli Essenziali di Assistenza* Prestazioni garantite dal SSN su tutto il territorio nazionale.

**UE** – *Unità Erogante* Struttura/servizio che effettua la prestazione prenotata.

### **Canali e servizi di accesso**

**116117** – Numero Europeo Armonizzato

Servizio telefonico di triage per bisogni non urgenti.

**CA** – Continuità Assistenziale

Servizio medico territoriale attivo nelle ore di chiusura dei MMG/PLS.

**Servizio/Segretariato Sociale** –

Accesso ai servizi di welfare territoriale e supporto sociale.

### **Termini applicativi e infrastrutturali**

**Tracciato posizionale** –

File a lunghezza fissa utilizzato nei flussi regionali e NSIS.

**Chiavi di relazione** –

Identificativi che collegano i tracciati riferiti alla stessa presa in carico o episodio.

**Validazione formale/logica** –

Controllo di lunghezze, domini e coerenze prima della trasmissione.

**Periodicità degli invii** –

Cadenze differenziate per ciascun flusso (mensile, trimestrale, annuale).

**Pipeline di invio** –

Processo di generazione, validazione, trasmissione e rettifica dei file.



# Modello Informativo: Percorsi, Flussi NSIS e Flussi Regionali

## Distinzione tra Percorsi, Flussi NSIS e Flussi Regionali

Nel contesto della sanità territoriale è essenziale distinguere tre livelli concettuali che cooperano ma non coincidono; **i percorsi assistenziali, i flussi informativi nazionali (NSIS) e i flussi informativi regionali.**

La chiarezza di questa distinzione permette di evitare sovrapposizioni terminologiche e interpretative.

### 1. Percorsi (DM 77/2022) – Il modello organizzativo

I percorsi rappresentano l'**organizzazione e l'operatività** dei servizi territoriali: come il cittadino accede, viene valutato, viene preso in carico e come i diversi attori interagiscono. Sono definiti dal DM 77/2022 e dalle linee regionali e includono:

- accesso tramite PUA, 116117 e servizi sociali,
- coordinamento tramite COT,
- strutture e servizi territoriali (OdC, URT, Hospice, ADI, CAD, UCP-DOM),
- raccordi con MMG/PLS, UVMD, Distretto, Ospedale.

I percorsi descrivono **chi fa cosa, quando e per quale motivo** nell'ambito del processo assistenziale. Non costituiscono flussi informativi.

### 2. Flussi NSIS – Il modello informativo nazionale

I flussi NSIS sono tracciati standardizzati stabiliti dal Ministero della Salute per rilevare, in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale, le attività erogate dai servizi sanitari. Sono utilizzati per:

- monitorare i LEA,
- supportare la programmazione nazionale e regionale,
- garantire uniformità e confrontabilità,
- produrre indicatori di qualità e outcome.

Ogni flusso NSIS corrisponde a un **ambito assistenziale**, ma non rappresenta un percorso: rileva ciò che viene erogato, non le dinamiche organizzative del processo.

L'elenco dettagliato dei flussi NSIS verrà presentato più avanti, insieme al **Grafico 1 – Alberatura NSIS.**

I flussi NSIS non descrivono i percorsi DM 77; registrano dati di attività, non la sequenza operativa del processo.

### 3. Flussi Territoriali/Regionali – Il modello informativo Veneto

Accanto ai flussi NSIS, il Veneto mantiene una propria struttura informativa regionale, che:

- integra gli standard nazionali,
- gestisce flussi storici (es. URT regionale),
- applica tracciati e periodicità specifici,
- recepisce i nuovi flussi NSIS in fasi progressive (es. SIOC),
- supporta il governo regionale dei percorsi e delle risorse.

I flussi regionali documentano attività e caratteristiche specifiche del territorio e non devono essere confusi con:

- i percorsi DM 77,
- i flussi NSIS nazionali.

I flussi regionali non sono percorsi, e non sempre sono identici ai flussi NSIS; sono **strumenti informativi** a supporto della programmazione territoriale regionale.



## **Caratteristiche generali dei flussi informativi (NSIS e regionali)**

I flussi informativi, sia nazionali che regionali, condividono alcune caratteristiche fondamentali:

### **a) Tracciati strutturati**

Ogni flusso è composto da uno o più **tracciati**, ovvero file standard che raccolgono:

- anagrafica dell'episodio,
- presa in carico,
- attività erogate,
- rivalutazioni,
- conclusione del percorso,
- eventuali scale, esiti o ore professionali.

### **b) Identificativi coerenti**

I tracciati utilizzano chiavi per collegare le varie fasi dello stesso episodio  
(presa in carico → attività → conclusione).

### **c) Modello posizionale**

I file sono quasi sempre a **lunghezza fissa (TXT posizionale)**, secondo regole regionali o nazionali.

### **d) Validazione multilivello**

La trasmissione prevede:

1. **generazione dei file dai sistemi aziendali,**
2. **validazione formale e logica** (lunghezze, domini, coerenze),
3. **accettazione regionale,**
4. **trasmissione al Ministero** quando previsto.

### **e) Periodicità variabile**

Ogni flusso prevede una periodicità specifica (mensile, trimestrale, annuale).

La periodicità è **per-flusso**, non uniforme.

**I percorsi territoriali rappresentano la struttura organizzativa dei servizi.**

**I flussi NSIS e regionali rappresentano la struttura informativa che rileva le attività erogate.**

**I due livelli operano in modo coordinato ma distinto.**



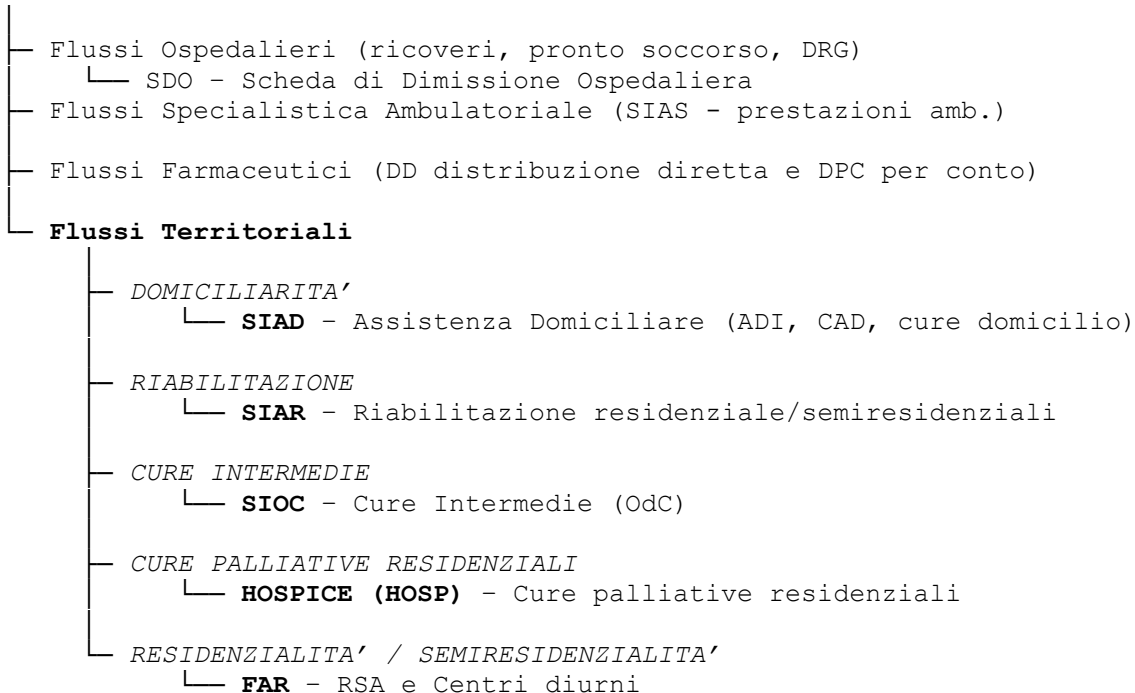


## Introduzione ai grafici dei flussi

Nelle pagine seguenti vengono presentate tre rappresentazioni grafiche che sintetizzano il modello informativo applicato alla sanità territoriale. Il primo grafico illustra l'alberatura dei flussi NSIS, organizzata per ambiti assistenziali secondo la struttura informativa nazionale. Il secondo rappresenta i flussi regionali utilizzati dal Veneto, evidenziando elementi storici e componenti recepite dallo standard nazionale. Il terzo grafico descrive gli attori del modello organizzativo DM 77, separati dai flussi per evitare sovrapposizioni tra percorsi e rilevazioni informative. Queste tre viste offrono al lettore un quadro sintetico, coerente e complementare, utile a orientarsi tra percorsi, flussi nazionali e flussi regionali prima della descrizione dei flussi territoriali.

### Grafico 1 - Alberatura NSIS (flussi informativi rilevanti)

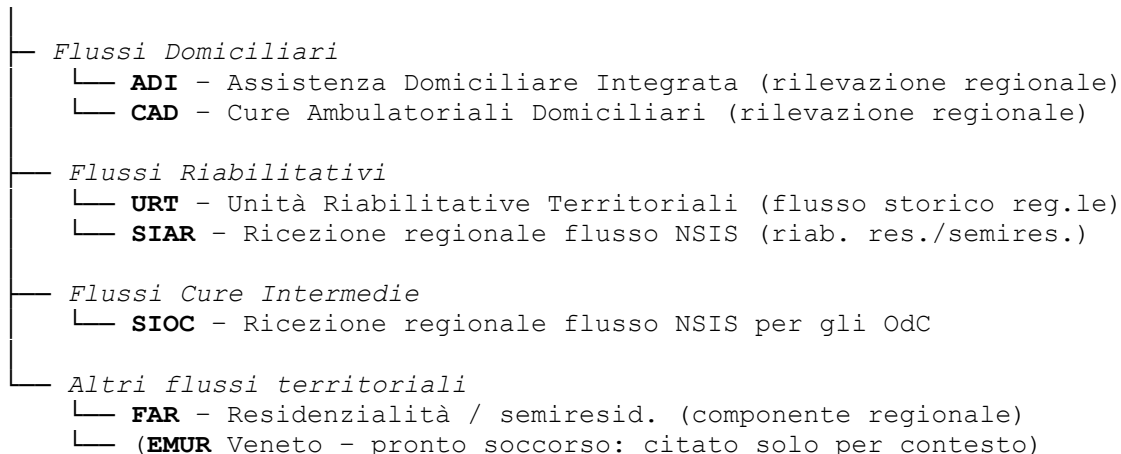
#### NSIS - Nuovo Sistema Informativo Sanitario



### Grafico 2 - Flussi informativi regionali del Veneto

La rappresentazione seguente sintetizza i principali flussi regionali utilizzati dal Veneto, in parte antecedenti o complementari ai flussi NSIS e rilevanti per la rilevazione delle attività territoriali.

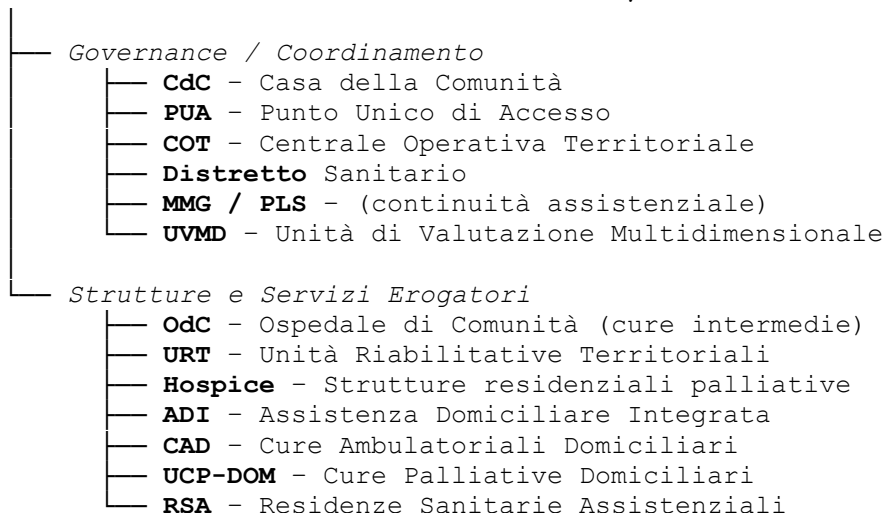
#### REGIONE VENETO - Flussi informativi territoriali



### Grafico 3 – Attori dell’assistenza territoriale (DM 77/2022)

La rappresentazione seguente sintetizza gli attori principali del modello organizzativo territoriale, distinti per ruolo di governance e di erogazione.

#### MODELLO ORGANIZZATIVO TERRITORIALE – DM 77/2022



La rappresentazione dei flussi NSIS, dei flussi regionali e degli attori del modello territoriale consente ora di introdurre i principali flussi informativi utilizzati nell’ambito dell’assistenza territoriale. Nelle sezioni successive vengono quindi descritti i flussi rilevanti per il territorio, con particolare riferimento alle attività domiciliari, riabilitative, intermedie, palliative e residenziali.



## Principali flussi in ambito territoriale

I flussi territoriali rappresentano la principale componente informativa dell'assistenza distrettuale. La presente sezione descrive i flussi rilevanti per i quattro ambiti assistenziali principali: **domiciliarità, riabilitazione, cure intermedie e cure palliative**, distinguendo i flussi **NSIS nazionali** dai flussi **regionali del Veneto**.

### 1. DOMICILIARITÀ

#### 1.1 Flusso NSIS: SIAD – Sistema Informativo Assistenza Domiciliare

Il flusso SIAD è la rilevazione nazionale unica per tutta l'assistenza domiciliare. Comprende:

- **ADI** – Assistenza Domiciliare Integrata
- **CAD** – Cure Ambulatoriali Domiciliari
- **Cure palliative domiciliari (UCP-DOM)**
- **Attività post-dimissione protetta**

**Struttura dei tracciati**

- **Tracciato 1** – Presa in carico
- **Tracciato 2** – Attività (accessi, rivalutazioni, sospensioni, conclusioni)

**Periodicità (standard NSIS)**

- Invio **trimestrale**
- Invio **non incrementale**: ogni trasmissione contiene **tutti** i record del periodo
- Finestra di rettifica nel periodo successivo

#### 1.2 Flussi regionali: ADI e CAD (Regione Veneto)

La Regione Veneto mantiene rilevazioni autonome dedicate a:

- **ADI – flusso regionale**
- **CAD – flusso regionale**

Questi flussi:

- esistono **indipendentemente dal SIAD**,
- rilevano contenuti operativi non previsti a livello nazionale,
- sono utilizzati per fini amministrativi, rendicontazione e governo regionale,
- rappresentano servizi distinti **nei percorsi territoriali**, pur venendo **ricondotti nel SIAD NSIS**.

**Periodicità dei flussi ADI/CAD regionali**

- Invio **mensile** (storico consolidato)
- Invio **non incrementale**: trasmissione completa del mese

### 2. RIABILITAZIONE

#### 2.1 Flusso NSIS: SIAR – Sistema Informativo Assistenza Riabilitativa

Il SIAR è il flusso nazionale per la riabilitazione residenziale e semiresidenziale.

**Introduzione normativa**

- Istituito con **DM 7 agosto 2023**
- **Sperimentale nel 4° trimestre 2023**
- **A regime dal 2024**

**Struttura dei tracciati**

- **Tracciato 1** – Presa in carico e valutazione iniziale
- **Tracciato 2** – Attività riabilitativa
- **Tracciato 3** – Ore dei professionisti (annuale)

**Periodicità NSIS**

- Tracciati 1-2: **invio trimestrale**
- Tracciato 3: **invio annuale**
- Rettifiche nei periodi successivi
- Invio **non incrementale**

**Cosa sostituisce**

→ **Sostituisce il flusso URT regionale storico**

come unica rilevazione nazionale della riabilitazione territoriale.



## 2.2 Flusso regionale storico: URT (Regione Veneto)

Prima dell'introduzione di SIAR, la Regione Veneto utilizzava il **flusso URT regionale** per monitorare le attività delle Unità Riabilitative Territoriali.

### Caratteristiche

- Invio **mensile**
- Invio **completo**, non incrementale
- Rilevazione delle attività riabilitative post-acuzie
- Usato per rendicontazione e programmazione regionale

### Stato attuale

- Con SIAR a regime, il flusso URT è **progressivamente dismesso**,
- Le URT continuano a esistere come strutture **DM 77**, ma non più come flusso principale.

## 3. CURE INTERMEDIE

### 3.1 Flusso NSIS: SIOC – Sistema Informativo Ospedale di Comunità

Il flusso SIOC rileva le attività degli **Ospedali di Comunità**, strutture di cure intermedie a bassa/media intensità clinica.

#### Introduzione normativa

- Istituito con **DM 04/08/2025**
- **Avvio sperimentale: 2026**
- **Obbligo di trasmissione: dal 01/01/2027**

#### Struttura dei tracciati NSIS

- **Tracciato 1** – Anagrafica assistito
- **Tracciato 2** – Ricovero

#### Periodicità NSIS

- Invio **trimestrale**
- Scadenza: **45 giorni** dalla fine del trimestre
- Finestra di **ulteriori 30 giorni** per integrazioni
- Invio **non incrementale**

#### Cosa sostituisce

→ È il **primo flusso nazionale** per le cure intermedie (non esisteva una rilevazione NSIS standard precedente).

### 3.2 Recepimento regionale Veneto (SIOC esteso)

La Regione Veneto recepisce il SIOC e lo **estende** con tre tracciati aggiuntivi, tramite:

- **DDR 138/2025** (adozione)
- **DDR 13745/2025** (tracciato definitivo)

#### Tracciati aggiuntivi regionali

- **Prestazioni/Attività**
- **Scale/Valutazioni funzionali**
- **Esiti/Dimissioni**

#### Periodicità regionale

- Allineata al formato NSIS (trimestrale)
- Invio **non incrementale**

## 4. CURE PALLIATIVE

### 4.1 Flusso NSIS: HOSPICE

È il flusso NSIS più consolidato del territorio.

#### Introduzione normativa

- Istituito con **DM 6 giugno 2012**
- A **regime dal 1 luglio 2012**

#### Cosa rileva

- Ricoveri in Hospice
- Attività clinico-assistenziale
- Durata, intensità, esiti

#### Periodicità

- Definita a livello regionale, con trasmissione regolare
- Invio **non incrementale** (standard NSIS)



#### 4.2 Cure palliative domiciliari: UCP-DOM (rilevazione via SIAD)

Le cure palliative domiciliari non dispongono di un flusso autonomo.  
Sono rilevate all'interno del **SIAD** come tipologia di assistenza domiciliare.  
Gli UCP-DOM:

- sono **servizi territoriali** nel modello DM 77,
- NON hanno un flusso separato,
- vengono distinti nel tracciato SIAD tramite classificazioni interne.



## Percorsi della sanità territoriale

La sanità territoriale, secondo il modello organizzativo del DM 77/2022, si fonda sulla capacità di accogliere il **bisogno del cittadino**, valutarlo in modo appropriato, attivare il servizio corretto e garantire continuità assistenziale fino alla conclusione del percorso.

In questa sezione vengono descritti esclusivamente gli aspetti **organizzativi** dei percorsi territoriali, senza alcun riferimento ai flussi informativi, che sono trattati in capitoli separati.

Il percorso territoriale può essere considerato come una sequenza articolata in fasi, ciascuna con attori e responsabilità specifiche.

### 1. Origine del bisogno

Il bisogno del cittadino può emergere da vari contesti:

- iniziativa diretta del cittadino presso servizi territoriali,
- telefonata al **116117** per bisogni non urgenti,
- valutazione o segnalazione da parte del **MMG/PLS**,
- attivazione da parte dei **Servizi Sociali / Segretariato Sociale**,
- richiesta derivante da una **dimissione ospedaliera**, con necessità di continuità assistenziale.

Questa fase ha l'obiettivo di intercettare tempestivamente il bisogno, senza ancora definire il percorso assistenziale.

### 2. Accesso al sistema territoriale

I principali punti di accesso ai servizi territoriali sono:

- **PUA (Punto Unico di Accesso)** Accoglie e registra il bisogno, effettua una prima categorizzazione e instrada verso l'attore competente.
- **116117** Fornisce triage telefonico per bisogni non urgenti, indirizzando il cittadino al PUA, alla Continuità Assistenziale o ad altri servizi.
- **Servizi Sociali / Segretariato Sociale** Intercettano bisogni socio-assistenziali che possono richiedere interventi sanitari.
- **MMG/PLS** Attivano i percorsi sanitari territoriali quando intercettano un bisogno clinico.

Il sistema territoriale, in questa fase, non eroga ancora interventi, ma prepara la valutazione strutturata del bisogno.

### 3. Valutazione del bisogno

La valutazione è il momento in cui il bisogno viene analizzato e "tradotto" in un percorso assistenziale. Gli attori principali sono:

- **PUA** – Effettua la valutazione preliminare organizzativa e identifica il possibile setting.
- **MMG/PLS** – Valutano la componente clinica e confermano la congruità del percorso.
- **UVMD** – Interviene nei casi complessi, definendo il **PAI (Piano Assistenziale Individuale)**.
- **Distretto sanitario** – Garantisce la coerenza organizzativa e l'integrazione tra servizi.

L'esito della valutazione determina il **setting definitivo**, che può essere: domiciliare, riabilitativo, intermedio, palliativo o sociale.

### 4. Percorsi post-ricovero e dimissione protetta

Quando il bisogno nasce in ospedale, assume particolare rilevanza la gestione della **dimissione protetta**, uno dei principali punti di attivazione della sanità territoriale.

#### 4.1 Dimissione protetta

- Il reparto ospedaliero segnala tempestivamente alla **COT** la necessità di continuità assistenziale post-ricovero.
- La COT valuta il caso, anche in raccordo con MMG/PLS e UVMD, e identifica il setting più appropriato.
- Si attiva il servizio territoriale corretto (ADI, OdC, URT, Hospice, ecc.), garantendo la continuità ospedale-territorio.
- Dove previsto, può intervenire il **case manager ospedaliero** quale facilitatore della transizione.



## 4.2 Dimissione assistita

Se il paziente non necessita di servizi territoriali strutturati, viene programmato un rientro al domicilio con eventuali controlli programmati presso servizi ambulatoriali. La distinzione tra dimissione protetta e assistita è fondamentale nell'organizzazione dei percorsi territoriali.

## 5. Coordinamento del percorso territoriale (COT)

La **COT – Centrale Operativa Territoriale** è il nodo di governance dei percorsi territoriali.

Le sue funzioni principali sono:

- coordinare la transizione ospedale → territorio,
- attivare il servizio territoriale adeguato al bisogno,
- monitorare l'andamento del percorso assistenziale,
- supportare i casi complessi in collaborazione con UVMD e Distretto,
- garantire continuità comunicativa con MMG/PLS, PUA e servizi erogatori,
- presidiare le criticità che emergono durante il percorso,
- verificare che l'assistenza sia coerente con il PAI nei casi multidimensionali.

### NOTA

*PUA, COT e 116117 non erogano prestazioni: intercettano, valutano e instradano il bisogno verso l'Unità Erogante competente. L'erogazione avviene solo presso i servizi territoriali (ADI, CAD, UCP-DOM, OdC, URT, Hospice, RSA) e solo tali strutture alimentano i flussi informativi pertinenti.*

## 6. Attivazione dei servizi territoriali

Una volta definito il setting, vengono attivati i servizi erogativi:

- **Assistenza domiciliare (ADI, CAD, UCP-DOM)**  
Interventi a domicilio, con intensità variabile a seconda del bisogno.
- **Riabilitazione territoriale (URT)**  
Percorsi riabilitativi post-acuzie o per disabilità.
- **Cure intermedie (Ospedale di Comunità)**  
Ricoveri brevi a bassa/media intensità clinica.
- **Cure palliative residenziali (Hospice)**  
Preso in carico in fase avanzata o terminale.

Questi servizi costituiscono la fase di erogazione vera e propria del percorso territoriale.

## 7. Conclusione del percorso

Il percorso si considera concluso quando:

- il bisogno è stato soddisfatto,
- l'assistenza erogata ha raggiunto gli obiettivi,
- il cittadino può rientrare al domicilio in sicurezza,
- eventuali follow-up sanitari o sociali sono stati programmati.

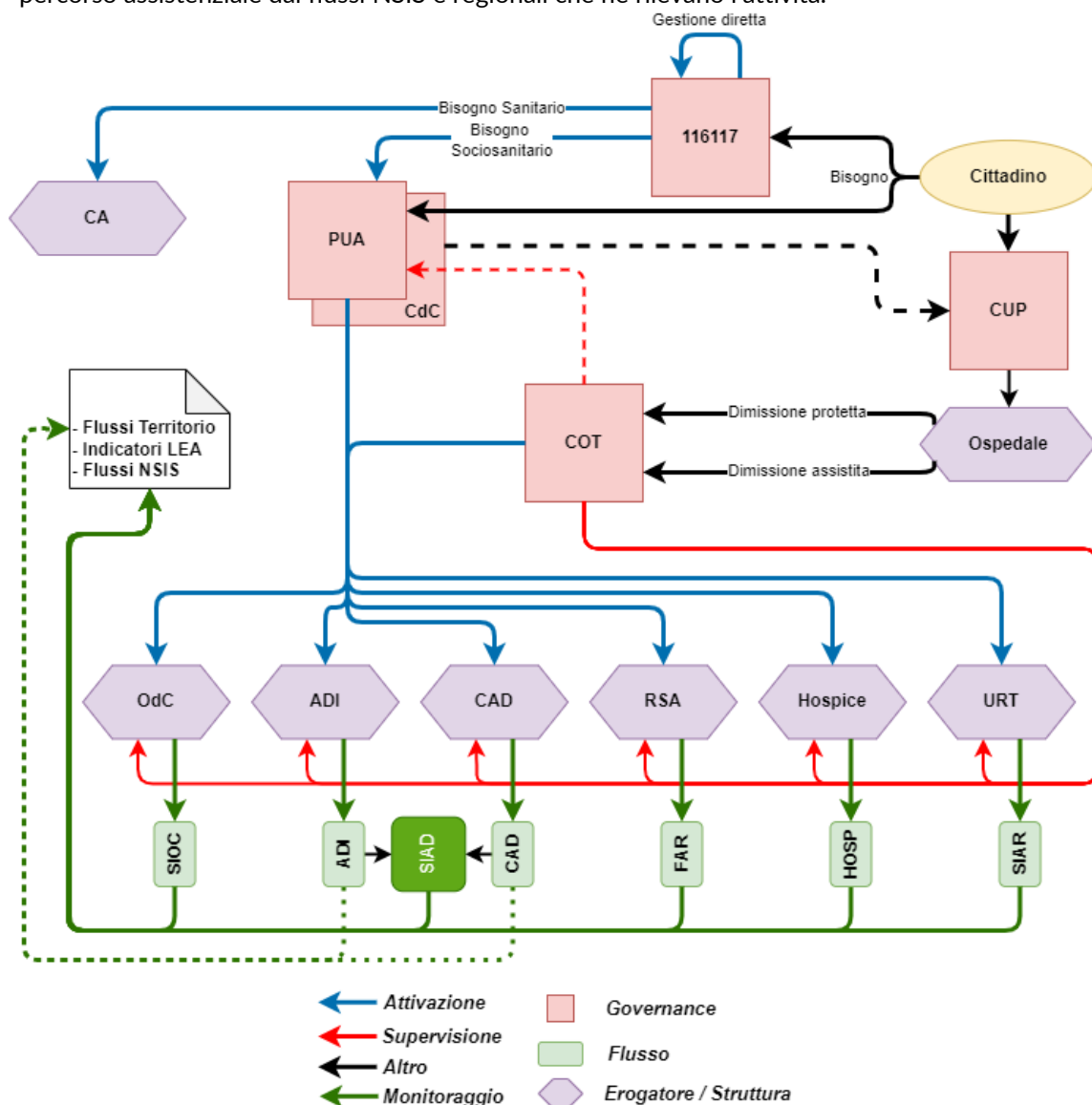
È importante ricordare che la **chiusura del percorso assistenziale** è un fatto **organizzativo**, mentre la **chiusura dei flussi informativi** è un fatto **tecnico-informativo** dei sistemi degli erogatori. I due aspetti restano distinti.

I percorsi della sanità territoriale descrivono la sequenza organizzativa con cui il bisogno del cittadino viene intercettato, valutato, smistato, erogato e concluso. Essi rappresentano il modello operativo dei servizi territoriali e non coincidono con i flussi informativi, che si limitano a rilevare le attività effettuate dai servizi.



## Diagramma “Attori-Governance-Flussi” (DM 77/2022 - NSIS)

Il diagramma seguente rappresenta la relazione tra attori, governance, servizi erogativi e flussi informativi all'interno del modello territoriale. Le connessioni mostrate distinguono chiaramente il percorso assistenziale dai flussi NSIS e regionali che ne rilevano l'attività.



### Note di interpretazione

- Gli attori di accesso e governance (PUA, COT, 116117, MMG/PLS, CdC, Distretto) non erogano prestazioni:** intercettano, valutano o coordinano il bisogno del cittadino.
- Le prestazioni sono erogate esclusivamente dai servizi territoriali (ADI, CAD, UCP-DOM, OdC, URT, Hospice, RSA), che rappresentano il livello operativo dei percorsi.**
- I flussi informativi (SIAD, SIAR, SIOC, HOSPICE, FAR) rilevano le attività erogate e non descrivono i percorsi:** documentano ciò che viene effettivamente erogato nel servizio competente.
- Il luogo fisico non determina il flusso informativo:** il flusso è generato dal servizio erogatore, indipendentemente da dove si trova il cittadino (es. ADI in RSA → flusso SIAD).
- Il diagramma rappresenta livelli distinti e complementari:**
  - attori* → gestiscono il bisogno,
  - erogatori* → forniscono le prestazioni,
  - flussi* → registrano le attività erogate.





## **PUA – Funzioni, organizzazione e implementazione applicativa**

Il **Punto Unico di Accesso (PUA)** rappresenta l'ingresso ordinato e strutturato del cittadino ai servizi sanitari e sociosanitari territoriali, secondo le linee guida del **DM 77/2022** e delle declinazioni regionali.

La sua funzione principale è **intercettare il bisogno, valutarlo in modo preliminare, identificare il setting appropriato e instradare** il caso verso l'attore operativo competente, garantendo equità, uniformità e trasparenza nell'accesso alla rete territoriale.

Il PUA non è un servizio erogativo e non produce flussi informativi: opera come nodo di accoglienza, analisi organizzativa e smistamento. L'erogazione dell'assistenza avviene sempre presso i servizi dedicati (ADI, CAD, UCP-DOM, OdC, URT, Hospice, RSA), mentre il PUA governa la fase iniziale del percorso.

### **1. Ruolo e finalità**

Il PUA:

- accoglie il cittadino e identifica la natura del bisogno (sanitario, sociosanitario, sociale),
- effettua la **valutazione preliminare**,
- classifica il bisogno in base a intensità, complessità e urgenza,
- identifica il **setting definitivo** richiesto (domiciliare, riabilitativo, intermedio, palliativo, sociale),
- smista verso l'attore competente (COT, UVMD, servizio erogante, servizi sociali),
- garantisce uniformità nell'accesso ai servizi della Casa della Comunità.

Il PUA opera in integrazione con MMG/PLS, 116117, servizi sociali, Distretto e COT.

### **2. Collocazione nel modello territoriale**

Il PUA agisce nel punto di contatto tra cittadino e rete territoriale. Il bisogno può raggiungere il PUA attraverso:

- accesso diretto del cittadino,
- invio dal **116117** per bisogni non urgenti,
- segnalazione da **MMG/PLS**,
- servizi sociali / segretariato sociale,
- richiesta derivante da **dimissione ospedaliera**, quando la COT valuta opportuno coinvolgere il PUA.

Il PUA può essere co-localizzato nella **Casa della Comunità**, ma non dipende gerarchicamente da essa: la collocazione è funzionale all'integrazione dei servizi.

### **3. Funzioni operative**

#### **3.1 Accoglienza e registrazione del bisogno**

- raccolta informazioni preliminari,
- analisi della domanda del cittadino,
- inquadramento organizzativo del bisogno.

#### **3.2 Valutazione preliminare**

- identificazione del setting più appropriato,
- verifica criteri di accesso,
- coinvolgimento MMG/PLS per chiarimenti clinici,
- attivazione UVMD nei casi multidimensionali.

#### **3.3 Smistamento verso gli attori competenti**

Il PUA può smistare:

- **verso la COT**, per bisogni complessi o post-ricovero,
- **verso la UVMD**, per valutazioni multidimensionali,
- **verso i servizi erogatori** (ADI, CAD, UCP-DOM, OdC, URT, Hospice),
- **verso servizi sociali**, quando prevale la componente sociale,
- **verso MMG/PLS**, quando il bisogno è clinico e non richiede percorso territoriale strutturato.

#### **3.4 Comunicazione e raccordo**

- mantiene il contatto con il cittadino durante la fase preliminare,
- coordina con Distretto, COT, servizi sociali, MMG/PLS,
- può programmare colloqui o visite preliminari presso il servizio destinatario.



#### 4. Relazioni con gli altri attori del territorio

##### **PUA ↔ COT**

Collaborazione stretta:

- il PUA gestisce bisogni semplici o moderati,
- la COT gestisce casi complessi e tutte le **dimissioni protette**.

##### **PUA ↔ UVMD**

Il PUA attiva la UVMD quando serve valutazione multidimensionale.

##### **PUA ↔ Distretto**

Il Distretto garantisce supervisione organizzativa e capacità di integrazione.

##### **PUA ↔ MMG/PLS**

Forniscono contributo clinico e continuità assistenziale.

##### **PUA ↔ 116117**

Riceve richieste non urgenti instradate dalla Centrale.

##### **PUA ↔ erogatori**

Non eroga prestazioni: li attiva.

#### 5. Cosa il PUA NON fa

Blocco chiarificatore essenziale.

Il PUA **non**:

- eroga prestazioni,
- produce flussi NSIS/regionali,
- prende in carico casi clinici complessi,
- sostituisce MMG/PLS,
- svolge funzioni di coordinamento (compito della COT),
- formula diagnosi cliniche.

**Il PUA non è un servizio erogativo ma un nodo di accesso, analisi e smistamento. Intercetta e categorizza il bisogno e lo instrada verso l'Unità Erogante competente, che effettuerà la prestazione e alimenterà il flusso informativo pertinente.**



## PUA – Modello funzionale offerto da RTI

### Mappatura e automazione (file di configurazione)

Nella fase iniziale di onboarding di una nuova ULSS è disponibile un file di configurazione da compilare, necessario per associare ogni bisogno alle **destinazioni operative** del sistema. Il file è composto da:

- **Codice/Descrizione del bisogno**
- **Destinazioni:**
  - **PUA (1° livello)** – se previsto per quel bisogno
  - **Centrale territoriale (2° livello)** – sempre valorizzata
  - **Setting definitivo / UE** – se adottato il modello completo
- **Ambito territoriale:** CAP e/o Comune di domicilio (una riga per CAP/comune)
- **Fallback:** PUA Master, destinazione di default per smistamenti non riusciti

### Livelli e attori

- **1° livello – PUA**  
Riceve la segnalazione, effettua la valutazione preliminare e smista verso la Centrale territoriale (2° livello) oppure direttamente al Setting/UE quando previsto dalla mappatura.
- **2° livello – Centrale territoriale**  
Valuta i casi instradati dal PUA e li assegna al Setting/UE.  
Nel modello semplificato utilizzato in alcune realtà pilota, può chiudere direttamente il bisogno quando non è previsto il livello di setting definitivo.
- **Setting definitivo / UE (Unità Erogante)**  
Prende in carico il caso, contatta il cittadino, programma l'intervento ed **avvia l'erogazione della prestazione prevista**, registrando data/ora del primo contatto, data/ora dell'erogazione e il motivo/evento sentinella associato.

### Modalità di smistamento dalla 116117

La Centrale 116117 non sceglie manualmente la destinazione; lo smistamento è automatico e guidato dalla mappatura.

- **Indiretto:** La richiesta passa al 1° livello (PUA), che smista al 2° livello e poi al setting definitivo.
- **Diretto:** La richiesta salta il 1° livello (PUA) e invia al 2° livello (per bisogni semplici)
- **Ibrido:** coesistenza di diretto e indiretto per tipologia di bisogno (categorizzato nel file di mappatura).

### Regole operative

- Le richieste provenienti da **116117** sono gestite esclusivamente secondo mappatura (**CAP/Comune + tipologia di bisogno**).
- Il **2° livello applicativo** è sempre presente, così come il **setting definitivo/UE** quando previsto dal modello adottato.
- È previsto un **PUA Master** come destinazione di default per smistamenti non riusciti e per riassegnazioni.
- Per esigenze di gestione regionale, la richiesta si **considera chiusa** quando viene assegnata al setting definitivo/UE. Eventuali percorsi successivi non impediscono la chiusura della richiesta originaria.
- **Rendicontazione settimanale:** estrazione dei bisogni chiusi e dei tempi (ingresso → primo contatto → erogazione), con motivazione/evento associato.

### Governance – PUA Master

Il **PUA Master**, con visibilità trasversale sulle richieste:

- monitora i **flussi di smistamento**,
- intercetta smistamenti non riusciti o code di default,
- effettua riassegnazioni manuali e correzioni senza entrare nell'operatività dei singoli livelli.



## Stati minimi e transizioni

Lo stato segue la sequenza: **In carico** → **In Valutazione** → **Valutata (valutata idonea)** → **Assegnata** → **Erogata** → **Chiusa**.

Quando il 2° livello rifiuta o reindirizza, la scheda torna al PUA o viene riassegnata ad altra Centrale di pari livello.

## Semantica di chiusura

Il bisogno si considera **chiuso** quando l'unità responsabile dell'erogazione (Setting/UE, o il 2° livello nel modello semplificato eventualmente adottato) ha soddisfatto la richiesta e registrato i dati minimi (primo contatto, erogazione, motivo/evento).

Eventuali percorsi successivi non impediscono la chiusura della richiesta originaria.

## Rendicontazione essenziale

Cadenza settimanale: estrazione dei bisogni chiusi e dei tempi (ingresso → primo contatto → erogazione), con motivazione/evento a corredo della chiusura.

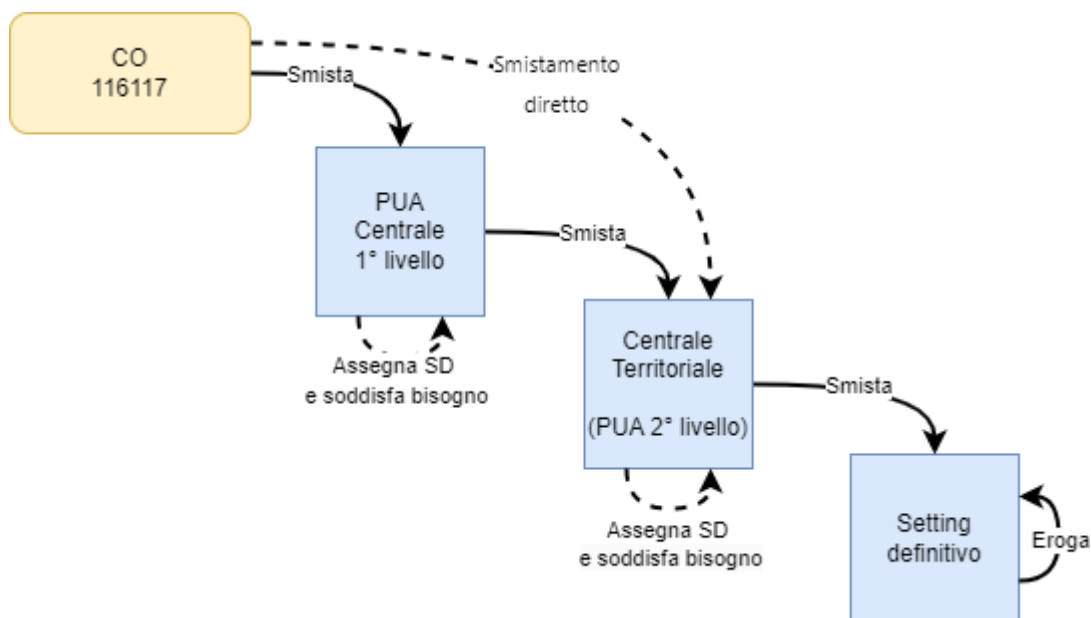
Dati minimi obbligatori:

- Data/ora primo contatto con l'utente,
- Data/ora erogazione del bisogno,
- Motivo/evento sentinella (tipizzato).

## Comunicazioni al cittadino (ingresso da 116117)

Invio SMS con ID scheda e messaggio di cortesia; informazioni solo di notifica/avviso (non equivalgono a presa in carico).

## PUA - Diagramma esteso



## PUA – Casi d'uso (esempi)

### 1 – Smistamento indiretto

**Bisogno:** es. consulenza ginecologica (consultorio familiare)

**Flusso:** 116117 → PUA (1° livello) → Centrale tematica (2° livello) → Setting/UE

**Stati (EPersonam):**

- PUA: In carico → Valutata → Assegnata (2° livello)
- 2° livello: Valutata → Assegnata (Setting/UE)
- Setting/UE: Erogata → Chiusa

**Dati minimi alla chiusura:** data/ora primo contatto; data/ora erogazione; motivazione/evento

**Chiusura:** La richiesta si chiude quando il Setting/UE registra l'avvio o l'esecuzione dell'intervento previsto.

---

### 2 – Smistamento diretto

**Bisogno:** semplice, indirizzabile senza passare dal PUA

**Flusso:** 116117 → Centrale di 2° livello → Setting/UE

**Stati (EPersonam):**

- 2° livello: In carico/Valutata → Assegnata (Setting/UE)
- Setting/UE: Erogata → Chiusa

**Dati minimi alla chiusura:** data/ora primo contatto; data/ora erogazione; motivazione/evento

**Chiusura:** la richiesta si chiude quando il Setting/UE registra l'avvio o l'esecuzione dell'intervento previsto. Il PUA non interviene nel flusso diretto.

---

### 3 – Smistamento ibrido

**Logica:** la mappatura distingue bisogni semplici (diretti) e complessi (indiretti).

A) Semplice

- Flusso: 116117 → 2° livello → Setting/UE
- Stati: Valutata → Assegnata → Erogata → Chiusa

B) Complesso

- Flusso: 116117 → PUA → 2° livello → Setting/UE
- Stati: PUA (Valutata → Assegnata) → 2° livello (Valutata → Assegnata) → Setting/UE (Erogata → Chiusa)

**Nota operativa:** la distinzione A/B è definita nel file di mappatura; la 116117 non sceglie manualmente.

---

### 4 – Modello semplificato (2° livello = UE)

**Bisogno:** gestito direttamente dalla Centrale di 2° livello (nessun Setting separato)

**Flusso:** 116117 → 2° livello (prende in carico, soddisfa e chiude il bisogno)

**Stati (EPersonam):**

- 2° livello: In carico/In valutazione → Erogata → Chiusa

**Dati minimi alla chiusura:** data/ora primo contatto; data/ora erogazione; motivazione/evento

**Chiusura:** la richiesta si chiude quando il 2° livello registra l'avvio o l'esecuzione dell'intervento previsto nel modello semplificato.

---

### 5 – Fallback PUA Master (governance/riassegnazione)

**Scenario:** smistamento non riuscito (CAP/comune non mappato, struttura non abilitata, ecc.)

**Flusso:** 116117 → PUA Master (catch-all) → riassegnazione manuale → PUA/2° livello /Setting corretto

**Stati (EPersonam):**

- PUA Master: In carico → Valutata → Assegnata (destinazione corretta)
- Unità erogante: Erogata → Chiusa

**Chiusura:** la richiesta si chiude presso l'Unità Erogante che prende in carico il caso. Il PUA Master non eroga: interviene solo per riassegnare correttamente il bisogno.



## COT - Funzioni, organizzazione e implementazione applicativa

### Ruolo

La **COT – Centrale Operativa Territoriale** coordina i percorsi assistenziali territoriali e garantisce il raccordo tra ospedale e territorio, in particolare nei casi di **dimissione protetta** e **dimissione assistita**.

Opera su segnalazione dei **reparti ospedalieri**, del **PUA** per i casi complessi e dei **MMG/PLS**, assicurando supervisione e attivazione dei servizi territoriali necessari.

La **COT non eroga prestazioni**: l'assegnazione non implica erogazione immediata. La presa in carico operativa e la prestazione vengono effettuate dall'**Unità Erogante (UE)** competente.

L'erogazione è registrata nei sistemi degli erogatori e **alimenta i flussi NSIS pertinenti**, non i sistemi COT.

### Segnalazioni in ingresso

- **Reparti ospedalieri**: dimissione protetta o assistita.
- **PUA**: casi complessi o che richiedono governance territoriale.
- **MMG/PLS**: necessità di attivare servizi territoriali.

### Azioni della COT

- **Supervisione** dei percorsi e delle transizioni organizzative.
- **Attivazione** e coordinamento dei servizi territoriali in base al bisogno.
- **Monitoraggio** dell'andamento dei percorsi e gestione delle criticità.
- **Raccordo** continuo con ospedale, PUA, MMG/PLS e servizi erogativi territoriali.

### Interfacce operative

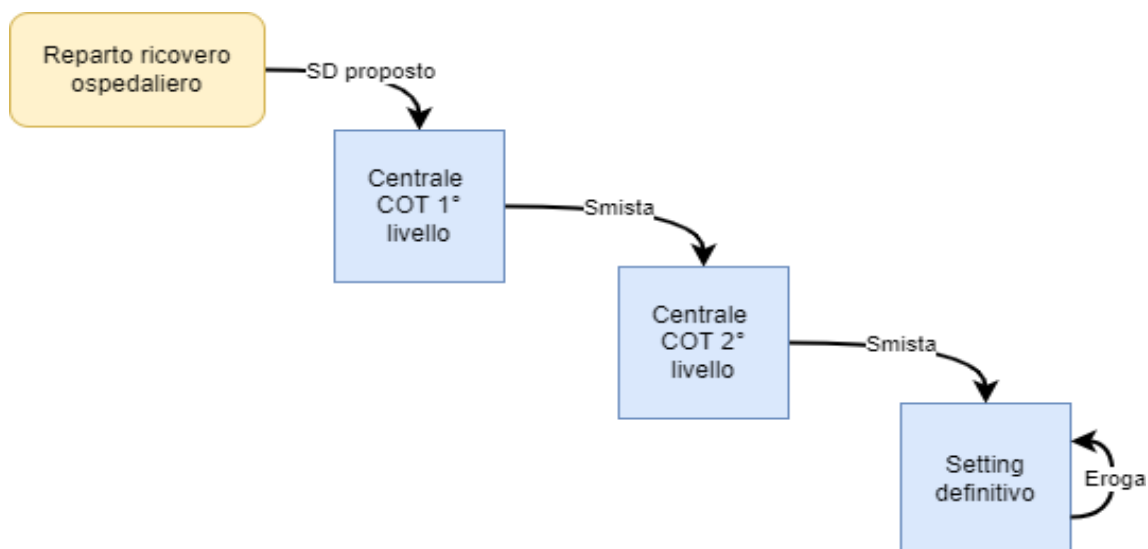
- **Ospedale**: riceve le segnalazioni di dimissione protetta/assistita e avvia il percorso territoriale.
- **PUA**: raccordo per i casi complessi e per confermare coerenza del setting.
- **MMG/PLS**: conferma clinica e continuità assistenziale.
- **Servizi territoriali**: attivazione dei setting assistenziali (ADI, CAD, UCP-DOM, riabilitazione presso URT, Ospedale di Comunità, Hospice). Quando viene attivato un ricovero in OdC, l'episodio rientra nel dominio operativo dell'Ospedale di Comunità.

### Nota terminologica

Le etichette **ADI, CAD, riabilitazione (URT), OdC e Hospice** indicano **setting organizzativi** del percorso e non la denominazione dei flussi informativi.

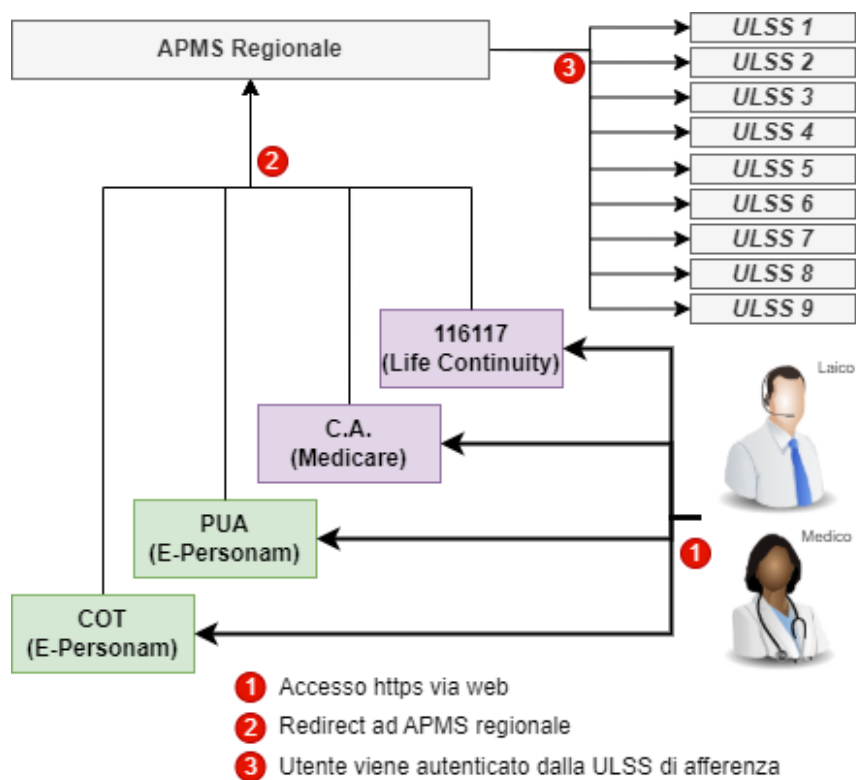
Sono utilizzate unicamente per descrivere il **percorso assistenziale**.

### COT Diagramma esteso

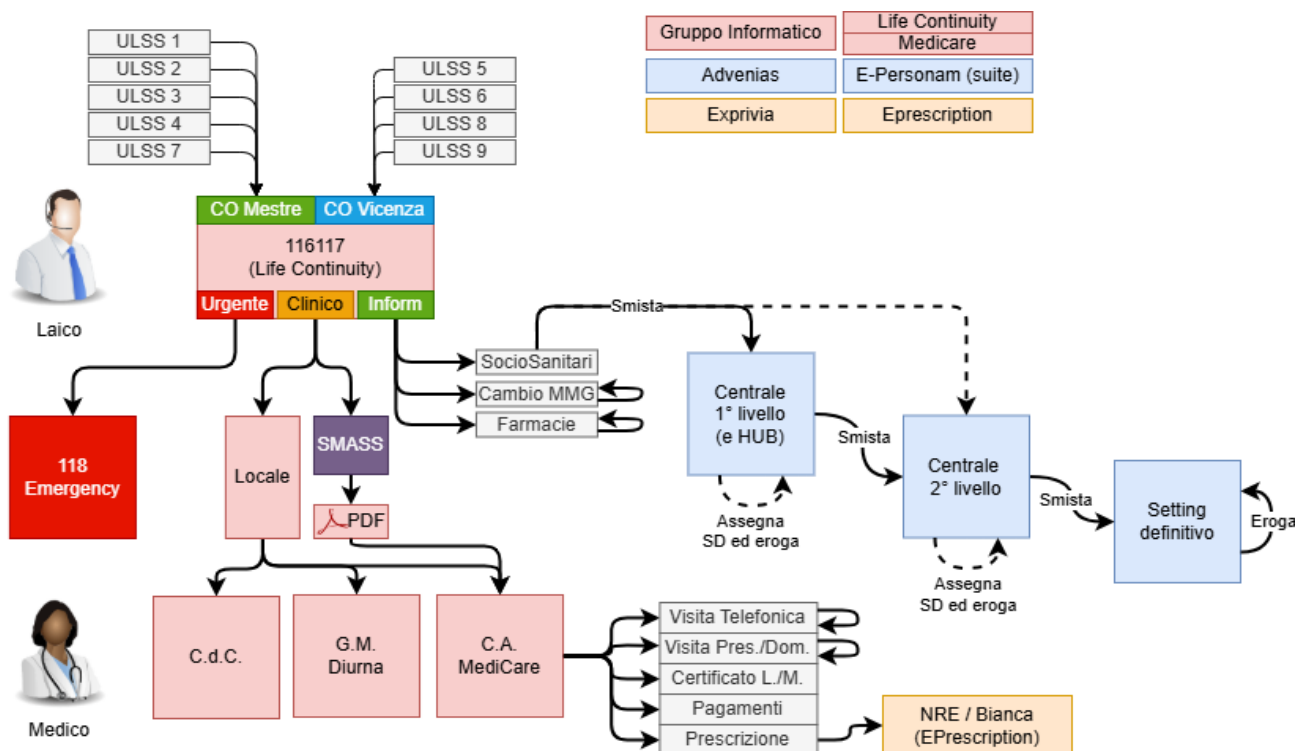


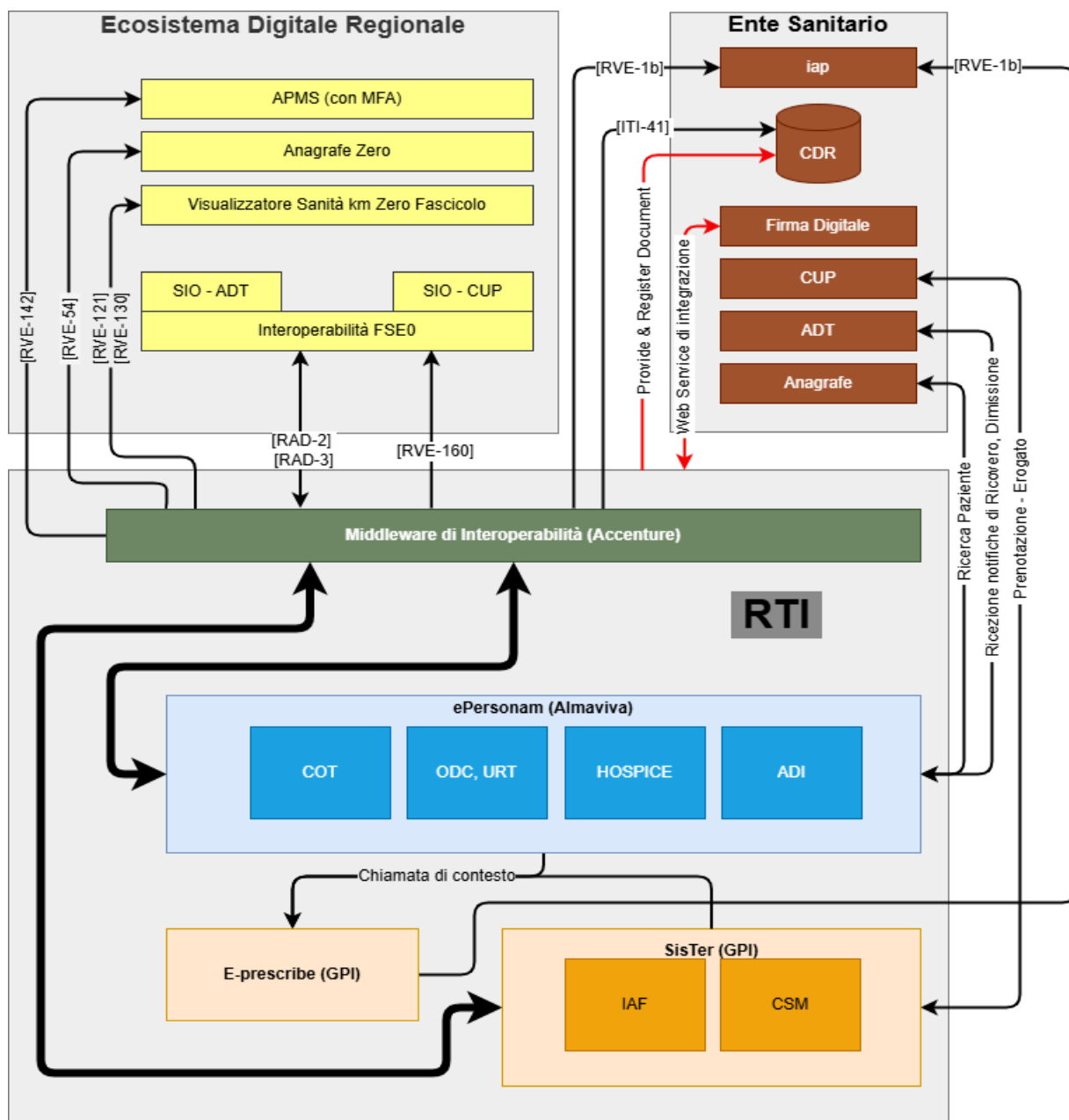
## Tavole Iconografiche

### Accesso operativo



### Operatività Applicativa





### Legenda

|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| [ITI-41]  | Provide & Register Document Set-b |
| [RVE-1b]  | Authenticate And Get Assertion-b  |
| [RVE-121] | Get Access Token                  |
| [RVE-130] | Chiamata Contesto                 |
| [RVE-142] | Initialize Authentication Flow    |
| [RVE-160] | Get Episode Data                  |
| [RVE-54]  | Patient Query                     |





## Appendice A – Note operative essenziali

### 116117 (LifeContinuity)

- *Obblighi* – Ci sono diversi campi obbligatori non chiaramente identificati
- *Icona* – all’inserimento del numero telefonico il sistema mostra presenza richieste precedenti
- *CAP* – importante indicare il CAP (dove si trova il cittadino) per identificare efficacemente l’UE
- *Invio* – una volta conclusa l’intervista, la richiesta va salvata e trasmessa per concludere l’iter.
- *Note* – la presenza di note è il modo in cui l’operatore può comunicare dettagli. Queste possono essere aggiunte (e trasferite) fino alla presa in carico del sistema a valle.
- *Chiusura automatica* – in caso di bisogno informativo il salvataggio prevede la chiusura diretta.

### CA (MedicalCare)

- *Logout* – Per l’uscita è importante la chiusura del turno, identifica la copertura e disponibilità.
- *Presenza* – Importante anche il flag assenza temporanea che supporta la copertura di servizio.
- *Erogazione* – L’erogazione avviene con la compilazione della scheda ed il suo salvataggio
- *Approfondimento* – Se a seguito del contatto si evidenzia la necessità di una visita in presenza la prestazione può essere duplicata. Si chiude quella telefonica e si predispone quella successiva. La visita telefonica non va mai sovrascritta; deve essere mantenuta come evento separato.
- *Automatismo* – Se l’esito del contatto telefonico prevede una visita in presenza, la duplicazione avviene in automatico.
- *Accesso diretto* – Se il paziente si presenta senza passare da 116117, il medico può inserire la prestazione direttamente da Prestazioni -> Visita.

### PUA – Comportamenti applicativi

In caso di richieste multiple successive dello stesso cittadino, l’operatore PUA può agganciare la nuova richiesta a una precedente se attinente allo stesso bisogno operativo (continuità del caso). In caso di errore di instradamento o CAP non mappato, la richiesta confluisce nel PUA Master, che effettua la riassegnazione manuale (non implica presa in carico). La chiusura della richiesta PUA dipende dalla registrazione del primo contatto e dell’erogazione a cura dell’unità destinataria.

### COT – Note operative (se servono)



## Appendice B – Implementazioni applicative attuali

Nel contesto attuale di gestione Al maviva (RTI) sono attivi degli applicativi per le aree specifiche.

| Area           | Applicativo     | Fornitore          | Caratteristiche                                                                                                                              |
|----------------|-----------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 116 117        | Life continuity | Gruppo informatico | sono disponibili le funzioni per gestire le centrali 116117, effettuare il triage telefonico e indirizzare la richiesta all'ente più idoneo. |
| CA             | Medical care    | Gruppo informatico | per continuità assistenziale (medico) presidio o guardia - gestione sanitaria                                                                |
| PUA            | E-Personam      | Advenias           | gestione setting definitivo bisogni di natura sociosanitaria                                                                                 |
| COT            | E-Personam      | Advenias           |                                                                                                                                              |
| ADI            | E-Personam      | Advenias           |                                                                                                                                              |
| OdC            | E-Personam      | Advenias           |                                                                                                                                              |
| Hospice        | E-Personam      | Advenias           |                                                                                                                                              |
| URT            | E-Personam      | Advenias           |                                                                                                                                              |
| Salute Mentale | Sis.Ter.        | GPI                |                                                                                                                                              |
| Consultorio    | Sis.Ter.        | GPI                |                                                                                                                                              |
|                |                 |                    |                                                                                                                                              |
|                |                 |                    |                                                                                                                                              |
|                |                 |                    |                                                                                                                                              |

Per ogni applicativo inserire le singole integrazioni previste



## Appendice C – Applicativi utilizzati rilevamento 06/2025 ( DRAFT )

|        | COT                            | ADI                     | OdC                 | Salute Mentale      | Consultorio                                                       | Hospice             | URT                 |
|--------|--------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| AULSS1 | PUA/COT                        | Atlante Modulo Base     | Atlante Modulo Base | Atlante Modulo Base | Atlante Modulo Base                                               | Atlante Modulo Base | Atlante Modulo Base |
|        | E-Personam                     | Atlante gestione tablet |                     |                     |                                                                   |                     |                     |
| AULSS2 | E-Personam                     | E-Personam              | E-Personam          | Sister              | Sister                                                            | N/A                 | E-Personam          |
| AULSS3 | E-Personam                     | ex ulss12 CarTer        | Atlante (ODC e URT) | Sister              | Sister                                                            | E-Personam          | E-Personam          |
|        |                                | ex ulss13 Atlante       |                     |                     |                                                                   |                     |                     |
|        |                                | ex ulss14 E-Personam    |                     |                     |                                                                   |                     |                     |
| AULSS4 | E-Personam                     | E-Personam              | N/A                 | Infoclin            | Icaro                                                             | N/A                 | N/A                 |
|        | Icaro                          | Icaro                   |                     |                     |                                                                   |                     |                     |
| AULSS5 | E-Personam                     | SISTE ^                 | SISTE ^             | SISTE               | SISTE                                                             | SISTE ^             | SISTE ^             |
| AULSS6 | SECC-COT                       | SIADI                   | SIADI               | DSM                 | POINT – Tutela minori<br>POINT - NPIA<br>POINT - Consultorio UOMI | N/A                 | SIADI               |
|        | Network Salute                 | Network Salute          | Network Salute      |                     |                                                                   |                     |                     |
| AULSS7 | E-Personam                     | Aster ^                 | Aster ^             | Aster ^^            | Aster ^^                                                          | N/A                 | N/A                 |
|        |                                |                         |                     | CUPWeb              |                                                                   |                     |                     |
|        |                                | Medtrack                | Medtrack            | Medtrack            |                                                                   |                     |                     |
| AULSS8 | E-Personam                     | Atlante                 | Atlante             | Atlante             | Atlante                                                           | Atlante             | Atlante             |
| AULSS9 | E-Personam                     | E-Personam              | E-Personam          | SISTE               | SISTE                                                             | E-Personam          | E-Personam          |
|        |                                |                         |                     |                     | CONSWEB (D1-2-4)                                                  |                     |                     |
| AOPD   | In uso sistemi AULSS6          | N/A                     | E-Personam          | POINT - PSM         | N/A                                                               | N/A                 | N/A                 |
| AOVR   | E-Personam                     | N/A                     | E-Personam          | N/A                 | N/A                                                               | N/A                 | N/A                 |
| IOV    | In uso sistemi AULSS2 e AULSS6 | N/A                     | N/A                 | N/A                 | N/A                                                               | E-Personam          | N/A                 |

### Legenda

| Applicativo             | Produttore              |
|-------------------------|-------------------------|
| E-Personam              | Advenias (RTI)          |
| Sister                  | GPI (RTI)               |
| Siter                   |                         |
| Aster                   |                         |
| SECC-COT                | Prometeo                |
| SIADI                   |                         |
| UOMI                    | Ciditech                |
| Network Salute          |                         |
| POINT - Tutela minori   |                         |
| POINT - NPIA            |                         |
| POINT - Consultorio     |                         |
| POINT - PSM             | Studio Vega             |
| DSM                     |                         |
| Atlante                 |                         |
| Atlante Modulo Base     |                         |
| Atlante gestione tablet | Intersystems            |
| PUA/COT                 |                         |
| Medtrack                | Maggioli                |
| TrakCare                |                         |
| Icaro                   | Perfexia                |
| CarTer                  |                         |
| CONSWEB                 | UOC Sistemi Informativi |
| Infoclin                | Dedalus                 |

|                               |
|-------------------------------|
| Applicativo RTI               |
| Swap o upgrade interno ad RTI |
| Applicativo in dismissione    |
| Nessun Applicativo            |



## Bibliografia

### Normativa nazionale (cornice organizzativa)

- DM 23 maggio 2022, n. 77 – Regolamento per modelli e standard dell'assistenza territoriale – [Gazzetta Ufficiale, 22/06/2022](#)
- DM 77/2022 – [testo su Normativa \(consultazione\)](#)

### Flussi NSIS di progetto (pagine ufficiali e atti istitutivi)

- SIAD – Sistema informativo Assistenza Domiciliare – Specifiche funzionali v7.4 (01/05/2024) – [Ministero della Salute](#)
- SIAR – Sistema informativo Riabilitazione residenziale/semiresidenziale –
  - [DM 07/08/2023 \(GU\) e pagina ministeriale GU](#)
  - [Pagina NSIS](#)
- SIOC – Sistema informativo Ospedali di Comunità –
  - [DM 04/08/2025 \(GU\) e pagina ministeriale GU](#)
  - [Pagina NSIS](#)
- HOSPICE – Monitoraggio dell'assistenza erogata presso gli Hospice – pagina ministeriale
  - [pagina ministeriale](#)

### Regione del Veneto

- DGR n. 976 del 27/08/2024 – Progetto sistema di risposta sanitaria 116117 – [BUR n.120 del 06/09/2024](#)
- DGR n. 4588 del 28/12/2007 – Linee di indirizzo UVMD (Allegato A) – BUR n.11 del 05/02/2008
  - [Dettaglio DGR](#)
  - [Allegato A \(UVMD\)](#)
- DGR n. 2961 del 28/12/2012 – Gestione informatica residenzialità extraospedaliera e aggiornamento SVaMA –
  - [BUR n.13 del 01/02/2013](#)
- DGR n. 96 del 04/02/2025 – Aggiornamento processo SVaMA –
  - [BUR n.23 del 14/02/2025](#)

### Operatività 116117 in Veneto

- ULSS 3 Serenissima – Centrale 116117: [descrizione operativa](#)

### Appendice

- DM 77/2022 – Allegati
  - [Allegato 1](#)
  - [Allegato 2](#)
- SIOC – nota stampa di contesto: [\(timeline avvio/obbligo\)](#)

